Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Parotidektomi

Kulak önü tükürük bezinin (parotis bezi) kısmen veya tamamen çıkarılması

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

İşlemin yapılacağı sağlık kuruluşu: _____

Taraf: ☐ Sağ ☐ Sol

Planlanan kapsam: ☐ Yüzeyel ☐ Parsiyel / ekstrakapsüler ☐ Total
☐ Ameliyatta belirlenecek _____

Yüz siniri monitörizasyonu: ☐ Kullanılacak ☐ Kullanılmayacak

Ön tanı (ince iğne biyopsisi / görüntüleme sonucu): _____

Tümör yüz sinirine yayılmışsa birlikte verilen karar: ☐ Gerekirse sinir dalı feda edilebilir ☐ Sinir korunsun ☐ Diğer _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Parotis bezi, her iki kulağın önünde ve hemen altında yer alan, tükürük üreten en büyük tükürük bezimizdir. Bezin içinden, yüz kaslarımızı hareket ettiren **yüz siniri (fasiyal sinir)** dallanarak geçer. Bu nedenle parotis ameliyatı, sinirin korunmasına özel dikkat gösterilerek yapılan hassas bir ameliyattır.

Parotidektomi en sık bezde gelişen **kitleler (tümörler)** nedeniyle yapılır. Bu kitlelerin büyük çoğunluğu (yaklaşık %80'i) **iyi huyludur**; en sık görülenler pleomorf adenom ve Warthin tümörüdür. İyi huylu kitleler de zamanla büyüyebilir ve bazıları (özellikle pleomorf adenom) uzun yıllar içinde kötü huylu hâle dönüşebilir. Daha az sıklıkla tekrarlayan iltihaplar, taşlar veya kötü huylu tümörler ameliyat gerektirir.

Ameliyatın amacı, kitleyi veya hastalıklı bez dokusunu **yüz sinirini koruyarak** tamamen çıkarmak ve kesin tanıyı patolojik inceleme ile koymaktır.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 İşlem nasıl yapılır?

Ameliyat genel anestezi altında, ameliyathane koşullarında yapılır. Ameliyattan önce ultrason, MR ve/veya ince iğne biyopsisi ile kitle değerlendirilir; bu tetkikler ön bilgi verir, ancak kesin tanı ameliyat sonrası patoloji ile konur.

1. **Kesi:** Kesi genellikle kulağın önündeki doğal kıvrımdan başlayıp kulak memesinin altından dolaşarak boyundaki bir cilt çizgisine uzanır. Uygun olgularda kesi daha kısa tutulabilir veya saç çizgisine gizlenebilir.
2. **Yüz sinirinin bulunması:** Cilt ve bez üzerindeki doku kaldırılır, yüz sinirinin ana gövdesi bulunur. Kullanılıyorsa **sinir monitörizasyonu** cihazı, sinirin yerini ve işlevini ameliyat boyunca izlemeye yardımcı olur.
3. **Kitlenin/bezin çıkarılması:** Sinir ve dalları dikkatle takip edilerek kitle, çevresinde bir miktar sağlam bez dokusuyla birlikte çıkarılır. Kitlenin yerine ve büyüklüğüne göre bezin yalnızca dış kısmı (yüzeyel), bir bölümü veya tamamı (total) çıkarılabilir.
4. **Patolojik inceleme:** Çıkarılan doku patolojiye gönderilir. Kesin sonuç genellikle 1–2 hafta içinde çıkar.
5. **Kapatma:** Kanama kontrolü yapılır, birikebilecek kan ve sıvının dışarı alınması için genellikle ince bir **dren** (hortum) yerleştirilir. Cilt ince dikişlerle kapatılır ve hafif baskılı pansuman uygulanabilir.

Tümör yüz sinirini sarıyor veya içine yayılmışsa (bu durum çoğunlukla kötü huylu tümörlerde görülür), tümörün tamamen çıkarılması için sinirin bir dalının veya tamamının feda edilmesi gerekebilir. Bu ihtimal ameliyat öncesinde sizinle **ayrıca konuşulur**; size danışılmadan beklenmedik şekilde sinir kesilmez, ancak tümörün sinirden ayrılamadığı durumda ne yapılacağı ameliyat öncesinde birlikte kararlaştırılır.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Genel anestezi	Yaklaşık 2–4 saat	Genellikle 1–2 gece; dren çıkınca taburculuk

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Kitlenin çıkarılması ve kesin tanının konulması
- İyi huylu kitlelerin büyümesinin, yüz sinirine baskı yapmasının ve uzun vadede kötü huylu hâle dönüşme riskinin önlenmesi
- Kötü huylu tümörlerde tedavinin ilk ve en önemli basamağı
- Tekrarlayan iltihap veya taşa bağlı ağrı ve şişliklerin sona ermesi

İyi huylu tümörlerin büyük çoğunluğunda ameliyat kalıcı tedavi sağlar. Uygun teknikle çıkarılan pleomorf adenomlarda tekrarlama oranı **100 hastada 1–2'nin altındadır**; ancak tümörün kapsülünün yırtılması veya daha önce ameliyat olmuş olmak bu oranı artırır. Warthin tümörü aynı veya karşı bezde yeni bir odak olarak ortaya çıkabilir. Kötü huylu tümörlerde sonuç, tümörün türüne ve evresine bağlıdır ve ek tedavi gerekebilir.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Takip (izlem):** Bazı küçük, iyi huylu olduğu düşünülen kitlelerde (özellikle yaşlı veya ameliyat riski yüksek hastalarda Warthin tümörü gibi) düzenli ultrason/MR ile takip seçeneği konuşulabilir. Bu durumda kitle yerinde kalır ve büyüyebilir; kesin tanı konamaz.
- **İlaç tedavisi:** İltihap ve taşa bağlı şikâyetlerde antibiyotik, bol sıvı alımı, masaj; uygun olgularda tükürük kanalı endoskopisi (siyalendoskopi) ile taş çıkarılması. Tümörlerde ilaç tedavisi bir seçenek değildir.
- **Radyoterapi:** Ameliyat edilemeyen kötü huylu tümörlerde veya ameliyata ek tedavi olarak kullanılır; iyi huylu tümörlerin tedavisinde tercih edilmez.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Ameliyat yapılmazsa kitle yerinde kalır ve kesin tanı konamaz. İyi huylu tümörler genellikle yavaş büyür ancak zamanla büyüyerek ameliyatı zorlaştırabilir ve yüz siniri için riski artırabilir; pleomorf adenomlar uzun yıllar içinde kötü huylu hâle dönüşebilir (yıllar içinde yaklaşık %5–10). Kötü huylu bir tümör ise tedavi edilmezse ilerler ve çevre dokulara, lenf bezlerine yayılabilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- Ameliyattan önce kan tahlilleri, görüntüleme (ultrason/MR) ve gerekirse ince iğne biyopsisi yapılır; anestezi uzmanı tarafından değerlendirilirsiniz.
- Ameliyattan önceki **6–8 saat** boyunca hiçbir şey yememeniz ve içmemeniz gerekir (anestezi uzmanının talimatlarına uyunuz).
- Erkek hastalarda kesi bölgesindeki sakal ve kulak çevresindeki kıllar ameliyat günü kısaltılabilir. Kesi yerine göre kulak arkasındaki saç bir miktar düzeltilebilir.
- Yüz ifadelerinizin ameliyat öncesi durumu kayıt altına alınmak üzere muayene edilir ve fotoğraflanır.
- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İlk 24–48 saat	Ameliyat bölgesinde gerginlik, hafif–orta düzeyde ağrı ve şişlik olur; ağrı kesicilerle kontrol edilir. Dren genellikle 1–2. gün, gelen sıvı azalınca çekilir. Başınızı yüksekte tutarak yatmanız önerilir. Yüz hareketleriniz kontrol edilir.
1. hafta	Taburcu olduktan sonra günlük işlerinize dönebilirsiniz. Dikişler genellikle **5–7. günlerde** alınır. Kulak memesi ve kulak önünde uyuşukluk belirgindir. Patoloji sonucu genellikle bu dönemde veya kısa süre sonra çıkar ve sizinle paylaşılır.
2–6. haftalar	Masa başı işe çoğunlukla 1–2 hafta içinde dönülür. Ağır egzersiz ve eğilip kaldırma gerektiren işler yaklaşık **2–3 hafta** ertelenmelidir. Yüz sinirinde geçici güçsüzlük olduysa genellikle haftalar içinde düzelmeye başlar; göz koruması ve yüz egzersizleri önerilir.
3–12. aylar	İz giderek solar. Kulak memesindeki uyuşukluk kısmen düzelir. Geçici sinir güçsüzlüğü olan hastaların büyük çoğunluğu 6–12 ay içinde tamamen iyileşir. Yemek yerken yanakta terleme (Frey sendromu) varsa bu dönemde ortaya çıkabilir.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- Ameliyat bölgesinde ağrı, gerginlik ve şişlik

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Kulak memesi ve kulak önü derisinde uyuşukluk
- Kesi yerinde iz (zamanla solar)
- Ameliyat tarafında çene açarken veya çiğnerken hafif ağrı (ilk günler)

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Geçici yüz siniri güçsüzlüğü** — Yaklaşık 100 hastadan **10–40'ında** (çıkarılan doku miktarına ve kitlenin yerine bağlı olarak) ağız kenarında, gözü kapatmada veya kaş kaldırmada geçici güçsüzlük olur. Çoğu zaman yalnızca bir daldadır ve **haftalar–aylar içinde** düzelir. Bu süre içinde gözünüz tam kapanmazsa göz kuruluğunu önlemek için damla, jel ve gece göz bandı kullanmanız gerekir.
- **Kulak memesinde kalıcı his kaybı** — Kulak memesine his veren sinir (büyük aurikülar sinir) çoğu ameliyatta etkilenir. Uyuşukluk hastaların çoğunda zamanla azalır, ancak kulak memesi ve çevresinde bir miktar his azlığı **kalıcı** olabilir. Bu durum genellikle günlük yaşamı etkilemez.
- **Frey sendromu (yemek yerken terleme)** — Yemek yerken ameliyat tarafında yanakta terleme ve kızarma. Testlerle bakıldığında daha sık görülse de, yaklaşık 100 hastadan **10–20'sinde** fark edilir hâldedir; genellikle aylar sonra başlar. Rahatsız edici olursa ter önleyici kremler veya **botulinum toksini** enjeksiyonu ile tedavi edilebilir.
- **Yanak bölgesinde çöküklük** — Çıkarılan doku miktarına göre kulak önünde hafif çukurluk ve iki taraf arasında farklılık oluşabilir. Belirginse yağ veya dolgu ile düzeltilebilir.

Seyrek görülen durumlar

- **Sıvı birikimi (serom) veya tükürük birikimi (siyalosel) / tükürük fistülü** — Yaklaşık 100 hastadan **5–10'unda** ameliyat bölgesinde sıvı veya tükürük birikebilir; nadiren ciltten dışarı sızıntı (fistül) olur. Genellikle iğne ile boşaltma, baskılı pansuman ve gerekirse botulinum toksini ile birkaç hafta içinde düzelir.
- **Kanama ve hematom** — Yaklaşık 100 hastadan **1–3'ünde** cilt altında kan birikebilir. Büyükse ameliyathanede boşaltılması ve kanamanın durdurulması gerekebilir.
- **Yara enfeksiyonu** — 100 hastada **1–3** oranında; genellikle antibiyotikle düzelir, nadiren iltihabın boşaltılması gerekir.
- **İlk lokma ağrısı (first-bite sendromu)** — Özellikle derin bölge ameliyatlarından sonra, yemeğin ilk lokmalarında çene açısında birkaç saniye süren keskin ağrı. Genellikle zamanla azalır.
- **Kitlenin tekrarlaması** — İyi huylu tümörlerde düşük olmakla birlikte, kitle aynı bölgede tekrar edebilir veya Warthin tümöründe yeni bir odak gelişebilir; bu durum yeniden ameliyat gerektirebilir. Tekrarlayan ameliyatlarda yüz siniri için risk daha yüksektir.
- **Kalın iz veya keloid** — Kişisel yatkınlığa bağlı olarak iz kalınlaşabilir; kortizonlu iğne veya diğer iz tedavileri uygulanabilir.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Kalıcı yüz siniri felci** — İyi huylu tümörlerde ilk ameliyatta yaklaşık 100 hastadan **1–3'ünde** yüz sinirinin bir dalında veya nadiren tümünde kalıcı güçsüzlük kalabilir. Bu durum ağız kenarında düşüklük, gözün tam kapanmaması, gülümsemede asimetri ve göz kuruluğu ile sonuçlanabilir; göz korunmazsa gözün saydam ön tabakasında (kornea) hasar ve görme kaybı gelişebilir. Kötü huylu tümörlerde, tekrar ameliyatlarında ve sinire yapışık kitlelerde bu risk daha yüksektir. Kalıcı felç gelişirse göz korunması için ilaçlar, göz kapağına ağırlık yerleştirilmesi, sinir onarımı veya yüz canlandırma ameliyatları gibi ek tedaviler gerekebilir.
- **Patoloji sonucunun ön tanıdan farklı çıkması** — Ameliyat öncesi tetkikler iyi huylu bir kitleyi düşündürse de kesin patoloji sonucu **kötü huylu** bir tümör gösterebilir. Bu durumda ek ameliyat (bezin kalan kısmının veya boyun lenf bezlerinin çıkarılması), radyoterapi veya başka tedaviler gerekebilir.
- **Boyunda büyük hematom ve nefes yolunun etkilenmesi** — Çok nadiren hızla büyüyen kan birikimi boyunda baskı yaparak yutma veya nefes alma güçlüğüne yol açabilir; bu bir acil durumdur; hemen ameliyathanede boşaltılması, nadiren nefes yolunun güvenceye alınması (entübasyon veya trakeotomi) gerekebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Cilt beslenme sorunları** — Kesi kenarında, özellikle kulak memesi altında, cildin beslenmesinin bozulmasına bağlı yara açılması; sigara içenlerde daha sıktır.
- **Kulak memesi şeklinde değişiklik veya kulak kepçesinde his bozukluğu** — Kesi ve sinir etkilenmesine bağlı nadir görülür.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Anestezi riskleri:** Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa riskleri (bulantı, boğaz ağrısı, diş hasarı, alerjik reaksiyon, çok nadiren kalp-akciğer sorunları) anestezi uzmanı tarafından ayrıca anlatılır ve **ayrı bir anestezi onam formu** ile onayınız alınır.
- **Kanama ve kan nakli:** Bu işlemlerde kan nakli ihtiyacı çok nadirdir. Ciddi bir kanamada kan veya kan ürünü verilmesi gerekebilir; bunun da kendine özgü (alerji, enfeksiyon gibi) çok nadir riskleri vardır.
- **Enfeksiyon:** Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu genellikle antibiyotikle tedavi edilir; nadiren drenaj (iltihabın boşaltılması) gerekebilir.
- **Bacak toplardamarlarında pıhtı (DVT) ve akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli):** Kısa süren baş-boyun ameliyatlarında çok nadirdir. Erken hareket etmek riski azaltır. Hormon ilacı kullanımı, sigara, obezite ve önceki pıhtı öyküsü riski artırır.
- **İlaç alerjisi:** Kullanılan ilaçlara, antiseptiklere, banda veya dikiş materyaline karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
- **Yara izi ve iyileşme sorunları:** Kişiden kişiye değişen iz oluşumu; çok nadiren kalın (hipertrofik) iz veya keloid gelişebilir.
- **Hayati risk:** Günümüzde planlı baş-boyun cerrahisinde ölüm son derece nadirdir; ancak hiçbir cerrahi girişimin riski tamamen sıfır değildir. Ciddi bir komplikasyon hâlinde yoğun bakım tedavisi gerekebilir ve kalıcı sakatlık gelişebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- **Boyunda veya yanakta hızla artan şişlik**, özellikle yutma veya nefes alma güçlüğü ile birlikteyse (acil durum — 112'yi arayınız)
- Dren veya yara yerinden **durmayan kanama**
- **38,5 °C üzerinde ateş**, yarada artan kızarıklık, ağrı, ısı artışı veya iltihaplı akıntı
- Yüz hareketlerinde **yeni ortaya çıkan veya artan güçsüzlük**
- Gözünüzü tam kapatamıyorsanız gözde **kızarıklık, batma, ağrı veya görme bulanıklığı**
- Yara yerinden **berrak sıvı sızması** veya kulak önünde giderek büyüyen yumuşak şişlik

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- Yara bölgesini ilk 48 saat ıslatmayınız; sonrasında size anlatıldığı şekilde ılık suyla kısa duş alabilirsiniz.
- İlk haftalarda çok ekşi ve tükürük salgısını belirgin artıran yiyeceklerden kaçınmanız, sıvı birikimi riskini azaltabilir.
- Yüz siniri güçsüzlüğü varsa gün içinde suni gözyaşı damlası, gece göz jeli ve göz bandı kullanınız; gözünüzü rüzgâr ve tozdan koruyunuz.
- İzi en az 6 ay güneşten koruyunuz (yüksek faktörlü güneş kremi).
- Patoloji sonucunu ve sonrasındaki takip planını mutlaka hekiminizle görüşünüz; iyi huylu tümörlerde de belirli aralıklarla kontrol önerilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

11 İşlem sırasında beklenmeyen durumlar, doku örnekleri ve kan ürünleri

İşlem sırasında önceden öngörülemeyen bir durumla karşılaşılırsa, hekiminiz yalnızca bu formda onay verdiğiniz işlemin kapsamında kalır. **Hayati tehlike veya ciddi organ zararı riski** olmadıkça onay vermediğiniz ek bir işlem yapılmaz; böyle bir durumda işlem uygun noktada sonlandırılır ve size sonradan bilgi verilerek karar birlikte alınır. Hayati tehlike durumunda ise hayatınızı veya organınızı korumak için gerekli acil müdahale yapılır.

İşlem sırasında çıkarılan dokular, gerekli görüldüğünde tanının kesinleştirilmesi için **patolojik incelemeye** gönderilir. Bu inceleme sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebilir.

Kan nakli ihtiyacı bu işlemlerde çok nadirdir; yalnızca hayati gerekliliği olan durumlarda uygulanır. Kan veya kan ürünü almayı kabul etmiyorsanız (örneğin inanç nedeniyle) bunu işlemden önce mutlaka bildiriniz; bu kararın olası sonuçları sizinle ayrıca konuşulur ve “Size özel bilgiler” bölümüne yazılır.

12 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

13 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa “yoktur” yazılır.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Hasta beyanı

- ☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- ☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.
- ☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.
- ☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.
- ☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.
- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.
- ☐ Yüz siniri ile kitle arasındaki ilişkinin ancak ameliyat sırasında kesin olarak görülebileceğini, kesin tanının ameliyat sonrası patoloji ile konacağını ve sonuca göre ek tedavi gerekebileceğini anladım.
- ☐ Tümörün yüz sinirine yayılmış olması hâlinde sinir ile ilgili ne yapılacağı ameliyat öncesinde benimle konuşuldu ve kararım hasta bilgileri bölümüne kaydedildi.

- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**
- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

15 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.